HELP_Organi_P24 — Groupe F — Lots 247, 248, 217 à 226 — 19 questions

Questionnaire de recherche médicale pour l'encyclopédie PROFILES (examen fédéral suisse). Paquet 24 sur 30.

Consignes

1. Tu réponds de façon sourcée, jamais de mémoire. Sources suisses d'abord (OFSP, Swissmedic, AIPS sur swissmedicinfo.ch, Tox Info Suisse, Fedlex, ASSM, FMH, sociétés suisses), puis européennes (ESC, ERS, ERC, EASL, ESCMID, ESE, EULAR, EAACI, KDIGO, EMA). Jamais de recommandation exclusivement américaine.
2. Pour chaque question : recommandation suisse en vigueur (société ou autorité, titre, année, URL) ; version la plus récente comparée à la version citée dans le « Contexte », avec les différences ; informations, doses, posologies, voies et adaptations (rein, foie, enfant, grossesse) selon l'AIPS, avec le numéro d'autorisation Swissmedic ; à défaut de source suisse, la recommandation européenne la plus récente.
3. Chaque réponse a sa propre source et son propre extrait mot pour mot, avec URL et date de consultation. Les formules « idem », « voir question X » ou une source recopiée sans extrait propre sont interdites.
4. Si aucune source fiable n'existe, écris « donnée non trouvée dans les sources consultées » et liste les sources consultées. N'invente jamais.
5. Au début, écris le nombre de questions reçues dans ce paquet. À la fin, rends exactement le même nombre de réponses, avec leurs numéros.
6. Fais ensuite auditer ce paquet par un agent distinct, en raisonnement élevé : URL existante, extrait présent dans la source, source suisse ou européenne la plus récente, dose conforme à l'AIPS. Il corrige ou marque « donnée non trouvée ». Il n'invente jamais.
7. Rends les réponses dans un Google Doc du dossier HELP nommé comme ce paquet, suivi de « _REPONSES ». Écris en français, en phrases verbales courtes.

Questions

F-038 — Haute — LOT 217 · SSP O6.4

Emplacement : evidence.json (LOT_217, dossier de preuves ; fichiers HTML du cours non encore produits) › not_found n° 8 (point 11 Prise en charge, certificat d'incapacité) ; lié au LOT_224

Contexte : Le dossier n'a trouvé la notion d'incapacité de travail limitée au poste (« arbeitsplatzbezogene Arbeitsunfähigkeit ») ni dans les lignes directrices SIM 2026 ni dans le guide ASSM/FMH.

Question : Comment les lignes directrices de la Swiss Insurance Medicine (SIM 2026) ou la jurisprudence suisse traitent-elles l'incapacité de travail limitée au poste de travail (conflit, mobbing) et ses conséquences pour l'assurance perte de gain et le délai de protection contre le licenciement (CO 336c) ? Citez la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité : titre, année, URL) qui fixe cette conduite. Comparez sa version la plus récente avec celle du cours et listez les différences. À défaut de source suisse, citez la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-039 — Haute — LOT 217 · SSP O6.4

Emplacement : evidence.json (LOT_217, dossier de preuves ; fichiers HTML du cours non encore produits) › not_found n° 10 et 12 (point 6 Cadre légal, harcèlement scolaire)

Contexte : Le DPMin et les lois scolaires cantonales n'ont pas été lus ; le dossier interdit de citer un âge de responsabilité pénale sans vérification ; la Revue médicale suisse 2026 (harcèlement scolaire et médecin traitant) n'a été lue qu'en résumé.

Question : Quel âge de responsabilité pénale fixe le DPMin (art. 3–4), quelles sanctions s'appliquent au cyberharcèlement entre mineurs, et quelle conduite du médecin traitant devant un harcèlement scolaire recommande une source suisse (RMS 2026, SSP, programme cantonal) ? Citez le texte en vigueur (Fedlex : RS, article, alinéa et lettre exacts, état de consolidation, URL) ou l'entrée Swissmedic/AIPS ou la décision officielle, avec date. Comparez avec la version citée dans le cours et signalez tout changement.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-040 — Haute — LOT 217 · SSP O6.4

Emplacement : evidence.json (LOT_217, dossier de preuves ; fichiers HTML du cours non encore produits) › not_found n° 11 (DX.10, trouble délirant / stalking)

Contexte : Les posologies des antipsychotiques du DX.10 et les outils validés d'évaluation du risque de violence dans le stalking n'ont pas été recherchés ou trouvés.

Question : Quels antipsychotiques et quelles posologies (IP suisse) s'emploient dans le trouble délirant de type érotomaniaque, et quels outils validés d'évaluation du risque (SRP, SAM) recommandent les sources européennes ou suisses (police cantonale, gestion des menaces) ? Donnez la posologie selon l'information professionnelle suisse en vigueur (AIPS, swissmedicinfo.ch : spécialité ®, titulaire, date de révision, URL) : dose, voie, rythme, durée et adaptations rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse et allaitement. Comparez avec la version citée dans le cours et signalez toute différence. À défaut d'IP suisse, citez la recommandation européenne la plus récente (titre, année, URL).

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-041 — Haute — LOT 217 · SSP O6.4

Emplacement : evidence.json (LOT_217, dossier de preuves ; fichiers HTML du cours non encore produits) ; LOT_218 LOT_218_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html (brouillon Appel A non audité) › LOT_217 not_found n° 13 ; LOT_218 not_found n° 1 et Bloc 2 › lacunes (218.12) ; LOT_219 not_found n° 5 ; LOT_220 not_found n° 7 ; LOT_221 not_found n° 3 ; LOT_226 uncertainties n° 13

Contexte : Le code de déontologie FMH n'a pas été lu sur fmh.ch : copies ISFM/SIWF (révision 2025) ou citation indirecte ; articles sur la non-discrimination, le secret, les certificats et l'intégration des directives ASSM non vérifiés.

Question : Quel est le texte en vigueur du code de déontologie de la FMH (version et date) pour les articles sur la non-discrimination, le secret professionnel, l'établissement des certificats médicaux (art. 34) et l'intégration des directives de l'ASSM (annexe), avec URL fmh.ch ? Citez le texte en vigueur (Fedlex : RS, article, alinéa et lettre exacts, état de consolidation, URL) ou l'entrée Swissmedic/AIPS ou la décision officielle, avec date. Comparez avec la version citée dans le cours et signalez tout changement.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-042 — Haute — LOT 217 · SSP O6.4

Emplacement : evidence.json (LOT_217, dossier de preuves ; fichiers HTML du cours non encore produits) › uncertainties n° 8 (point 11.B, pédiatrie)

Contexte : Le dossier signale que Swisspeddose harmonise des posologies pédiatriques hors indication de l'IP pour la fluoxétine et la sertraline.

Question : Quelles posologies pédiatriques de la fluoxétine et de la sertraline (dépression, TSPT, anxiété) publie Swisspeddose, et quelles indications pédiatriques l'IP suisse de chaque spécialité reconnaît-elle ? Donnez la posologie selon l'information professionnelle suisse en vigueur (AIPS, swissmedicinfo.ch : spécialité ®, titulaire, date de révision, URL) : dose, voie, rythme, durée et adaptations rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse et allaitement. Comparez avec la version citée dans le cours et signalez toute différence. À défaut d'IP suisse, citez la recommandation européenne la plus récente (titre, année, URL).

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-043 — Haute — LOT 217 · SSP O6.4

Emplacement : evidence.json (LOT_217, dossier de preuves ; fichiers HTML du cours non encore produits) › uncertainties n° 9, 11 (TSPT) ; aussi LOT_221 uncertainties n° 1 (allaitement) et LOT_226 uncertainties n° 1

Contexte : Le dossier arbitre : IP Zoloft® (TSPT chronique, max 200 mg) contre OMS 2013 et SGAD 2016 (50–150 mg) ; LOT_221 : la recommandation suisse 2016 cite la sertraline en allaitement, l'IP Zoloft® (août 2025) demande d'arrêter l'allaitement.

Question : Que prévoit l'IP suisse de Zoloft® en vigueur (indications TSPT et dépression, dose initiale et maximale, allaitement) et quelle position adoptent swisstis.ch et la recommandation suisse la plus récente sur l'emploi de la sertraline pendant l'allaitement ? Donnez la posologie selon l'information professionnelle suisse en vigueur (AIPS, swissmedicinfo.ch : spécialité ®, titulaire, date de révision, URL) : dose, voie, rythme, durée et adaptations rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse et allaitement. Comparez avec la version citée dans le cours et signalez toute différence. À défaut d'IP suisse, citez la recommandation européenne la plus récente (titre, année, URL).

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :

3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-035 — Moyenne — LOT 217 · SSP O6.4

Emplacement : evidence.json (LOT_217, dossier de preuves ; fichiers HTML du cours non encore produits) › not_found n° 1, 2, 3, 9 ; uncertainties n° 1, 2, 12 (point 3 Épidémiologie, futur cours LOT_217)

Contexte : Le dossier utilise l'OFS 2024 (ESS 2022 : 5,9 %/6,8 % de mobbing), le rapport HBSC fribourgeois (valeurs nationales lues sur figures), des chiffres internationaux de stalking (BFEG 2017 : aucune donnée suisse) ; prévalence du TSPT après mobbing et chiffres sur le harcèlement entre médecins non trouvés ; rapport Addiction Suisse n° 154 non lu.

Question : Quelles données suisses récentes existent sur la prévalence du harcèlement obsessionnel (stalking), du harcèlement scolaire et du cyberharcèlement (rapport national HBSC 2022, Addiction Suisse n° 154), du harcèlement au travail (SECO, ESS 2022) et du harcèlement entre médecins (ASMAC, FMH), et sur le TSPT consécutif ? Citez la source suisse primaire la plus récente (OFS, Obsan, OFSP, registre ou société savante : titre, année des données, URL, date de consultation). Signalez toute rupture de série. À défaut de donnée suisse, donnez la donnée européenne la plus récente en l'étiquetant comme telle.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-036 — Moyenne — LOT 217 · SSP O6.4

Emplacement : evidence.json (LOT_217, dossier de preuves ; fichiers HTML du cours non encore produits) › not_found n° 5 (point 6 Cadre légal, mobbing au travail)

Contexte : L'article 2 OLT 3 est cité d'après l'annexe de la brochure SECO ; le commentaire SECO de l'OLT 3 art. 2 (passages sur le mobbing) n'a pas été lu.

Question : Que disent le texte en vigueur de l'OLT 3 art. 2 et le commentaire officiel du SECO sur le mobbing et le harcèlement sexuel (obligations de l'employeur, définition opérationnelle), et quelle jurisprudence du Tribunal fédéral définit le mobbing ? Citez le texte en vigueur (Fedlex : RS, article, alinéa et lettre exacts, état de consolidation, URL) ou l'entrée Swissmedic/AIPS ou la décision officielle, avec date. Comparez avec la version citée dans le cours et signalez tout changement.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-037 — Moyenne — LOT 217 · SSP O6.4

Emplacement : evidence.json (LOT_217, dossier de preuves ; fichiers HTML du cours non encore produits) › not_found n° 7 (point 2 Définition, critère de Leymann)

Contexte : Le dossier ne dispose que de la fenêtre de 6 mois du NAQ-R et du critère « au moins un acte hebdomadaire » (Petrović 2016) ; le critère temporel de Leymann n'a pas été lu dans une source primaire.

Question : Quel critère opérationnel de durée et de fréquence (Leymann : au moins une fois par semaine pendant au moins 6 mois) retiennent une source primaire et la jurisprudence ou le SECO en Suisse, et quels seuils dichotomiques du NAQ-R sont validés ? Donnez la valeur seuil validée, la population de validation (suisse ou germanophone/francophone si possible), la sensibilité et la spécificité, avec la source primaire (titre, année, URL). Signalez toute recommandation suisse ou européenne qui adopte ce seuil.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-044 — Moyenne — LOT 217 · SSP O6.4

Emplacement : evidence.json (LOT_217, dossier de preuves ; fichiers HTML du cours non encore produits) ; LOT_222 evidence.json (LOT_222, dossier de preuves ; fichiers HTML du cours non encore produits) ; LOT_226 evidence.json (LOT_226, dossier de preuves ; fichiers HTML du cours non encore produits) › LOT_217 not_found n° 6 ; LOT_222 not_found n° 11 ; LOT_226 not_found n° 6 (GAD-7)

Contexte : Les dossiers citent le PHQ-9 ≥ 10 et le GAD-7 sans seuil numérique lu ; les seuils du MBI, du PCL-5 et de l'ITQ ne sont pas lus.

Question : Quels seuils validés (versions française ou allemande) et quelles sensibilité et spécificité s'appliquent au GAD-7 (≥ 10 ?), au PCL-5, à l'International Trauma Questionnaire (ITQ, TSPT et TSPT complexe) et au Maslach Burnout Inventory ? Donnez la valeur seuil validée, la population de validation (suisse ou germanophone/francophone si possible), la sensibilité et la spécificité, avec la source primaire (titre, année, URL). Signalez toute recommandation suisse ou européenne qui adopte ce seuil.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-045 — Haute — LOT 218 · SSP O6.5

Emplacement : LOT_218_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html (brouillon Appel A non audité) › Bloc 1 › point 11.B › tableau des œstrogènes (féminisation) ; evidence uncertainties n° 1 et 3

Contexte : Le cours suit la SSED 2026 : « Oestrogel 0,75–3 mg/j (= 1–6 pressions) » incohérent avec l'IP (1 pression = 0,75 mg) ; « Estradot 50–300 µg toutes les 72 h » ambigu (IP : libération par 24 h, patch max 100 µg/24 h) ; valérate d'estradiol jusqu'à 6 mg/j hors IP.

Question : Quelles doses d'œstradiol (gel, patch, valérate oral) recommande la ligne directrice SSED 2026 pour l'hormonothérapie d'affirmation féminisante, et comment se comparent-elles aux IP suisses d'Oestrogel®, d'Estradot® et de Progynova® (unités, rythme de changement des patchs, dose maximale) ? Donnez la posologie selon l'information professionnelle suisse en vigueur (AIPS, swissmedicinfo.ch : spécialité ®, titulaire, date de révision, URL) : dose, voie, rythme, durée et adaptations rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse et allaitement. Comparez avec la version

citée dans le cours et signalez toute différence. À défaut d'IP suisse, citez la recommandation européenne la plus récente (titre, année, URL).

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-046 — Haute — LOT 218 · SSP O6.5

Emplacement : LOT_218_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html (brouillon Appel A non audité) › Bloc 1 › point 11.B (masculinisation) et fenêtre « Bilan avant et sous hormonothérapie » (testostérone) ; evidence uncertainties n° 2

Contexte : Le cours cite l'énanthate de testostérone « s.c. mensuel » dans le texte SSED et « i.m. toutes les 3–4 semaines » dans le tableau ; l'IP Testoviron impose l'i.m. ; cible énanthate 14–24 nmol/L à mi-cycle ; cible de l'undécanoate non donnée.

Question : Quelle voie, quel intervalle et quelles cibles de testostéronémie (énanthate, undécanoate Nebido®, gel) recommande la SSED 2026, et quelles voies et posologies reconnaissent les IP suisses de Testoviron® Depot, de Nebido® et des gels de testostérone ? Donnez la posologie selon l'information professionnelle suisse en vigueur (AIPS, swissmedicinfo.ch : spécialité ®, titulaire, date de révision, URL) : dose, voie, rythme, durée et adaptations rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse et allaitement. Comparez avec la version citée dans le cours et signalez toute différence. À défaut d'IP suisse, citez la recommandation européenne la plus récente (titre, année, URL).

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-048 — Haute — LOT 218 · SSP O6.5

Emplacement : LOT_218_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html (brouillon Appel A non audité) › Point 6.6 (hyperkaliémie sous spironolactone) et fenêtre « Bilan » (créatinine, kaliémie) ; evidence uncertainties n° 3

Contexte : Le cours cite la SSED (spironolactone jusqu'à 300 mg/j, hors IP) et l'IP [S43] (contrôle des électrolytes) ; seuil de kaliémie, seuil de clairance pour éviter la spironolactone et mécanisme de l'hyperkaliémie : « donnée non trouvée ».

Question : Quelle dose de spironolactone, quel seuil de kaliémie et de DFGe pour réduire ou arrêter, et quel calendrier de contrôle recommandent la SSED 2026 et l'IP suisse d'Aldactone® ? Donnez la posologie selon l'information professionnelle suisse en vigueur (AIPS, swissmedicinfo.ch : spécialité ®, titulaire, date de révision, URL) : dose, voie, rythme, durée et adaptations rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse et allaitement. Comparez avec la version citée dans le cours et signalez toute différence. À défaut d'IP suisse, citez la recommandation européenne la plus récente (titre, année, URL).

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :

3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-050 — Haute — LOT 218 · SSP O6.5

Emplacement : LOT_218_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html (brouillon Appel A non audité) › Fenêtre « LPMéd art. 40 et mesures de conversion » ; Bloc 2 › lacunes (218.16) ; evidence not_found n° 5

Contexte : Le cours cite le projet d'art. 9 du Code pénal neuchâtelois (rapport 23.002 du 1.2.2023) et des lois vaudoises ; statut d'adoption « donnée non trouvée ».

Question : Les cantons de Neuchâtel, Vaud, Genève et d'autres ont-ils adopté une interdiction des thérapies de conversion (texte, date d'entrée en vigueur, sanction), et où en est l'interdiction fédérale (modification du CP, initiative parlementaire, vote du Parlement) au 22.10.2026 ? Citez le texte en vigueur (Fedlex : RS, article, alinéa et lettre exacts, état de consolidation, URL) ou l'entrée Swissmedic/AIPS ou la décision officielle, avec date. Comparez avec la version citée dans le cours et signalez tout changement.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-051 — Haute — LOT 218 · SSP O6.5

Emplacement : LOT_218_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html (brouillon Appel A non audité) › Fenêtre « LAMal et prise en charge » ; Bloc 2 › lacunes (218.17) ; evidence not_found n° 6

Contexte : Le cours reprend la CNE et la SSED : des assureurs imposent des exigences non conformes (test de vie réelle, âge minimal, psychiatrie préalable) ; jurisprudence du Tribunal fédéral « donnée non trouvée ».

Question : Quels arrêts du Tribunal fédéral (numéro, date) fixent la prise en charge LAMal des traitements d'affirmation de genre (chirurgie, hormonothérapie, épilation, délai d'observation de deux ans abandonné ou non) ? Citez le texte en vigueur (Fedlex : RS, article, alinéa et lettre exacts, état de consolidation, URL) ou l'entrée Swissmedic/AIPS ou la décision officielle, avec date. Comparez avec la version citée dans le cours et signalez tout changement.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-052 — Haute — LOT 218 · SSP O6.5

Emplacement : LOT_218_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html (brouillon Appel A non audité) › Bloc 2 › lacunes (218.18) ; DX incongruence de genre chez le mineur ; evidence not_found n° 7, 8 et uncertainties n° 8

Contexte : Le cours cite WPATH SOC 8 et Endocrine Society 2017 par la SSED et la CNE ; la Cass Review 2024, les restrictions suédoises et finlandaises des bloqueurs et l'AWMF 2025 (D/A/CH,

votes séparés de la SGKJPP) ne sont pas lus en texte intégral ; aucune ligne directrice suisse propre aux mineurs.

Question : Quelle position suisse officielle (SSPP/SGKJPP, SSED, ASSM, CNE, OFSP) sur la suppression pubertaire et l'hormonothérapie chez le mineur existe en 2026, et quelles différences opposent la ligne directrice AWMF 2025, la Cass Review 2024 et les recommandations suédoise et finlandaise ? Citez la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité : titre, année, URL). Comparez sa version la plus récente avec celle utilisée dans le cours et listez les différences. Précisez les doses éventuelles selon l'information professionnelle suisse (AIPS). À défaut de source suisse, citez la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-053 — Haute — LOT 218 · SSP O6.5

Emplacement : LOT_218_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html (brouillon Appel A non audité) › Bloc 2 › lacunes (218.14) ; dépistage chez les personnes trans ; evidence not_found n° 3

Contexte : Les intervalles du dépistage du cancer du col sont repris de la SSED 2026 ; la recommandation SSGO primaire n'est pas lue.

Question : Quels intervalles et quelles méthodes (cytologie, test HPV, auto-prélèvement) fixe la recommandation SSGO la plus récente pour le dépistage du cancer du col, et comment s'applique-t-elle aux hommes trans ayant un col ? Citez la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité : titre, année, URL). Comparez sa version la plus récente avec celle utilisée dans le cours et listez les différences. Précisez les doses éventuelles selon l'information professionnelle suisse (AIPS). À défaut de source suisse, citez la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-056 — Haute — LOT 218 · SSP O6.5

Emplacement : LOT_218_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html (brouillon Appel A non audité) › Bloc 2 › fenêtre « dépression respiratoire » et lacunes (218.10, 218.20) ; evidence not_found n° 10, 12 et uncertainties n° 7

Contexte : Le cours cite Infodrog et Euro-DEN Plus pour les mélanges GHB/GBL ; critères CIM de dépendance du chemsex, dosages toxicologiques du GHB, LStup et prévalence (17,2 % dans les cohortes SHCS/SwissPrEPared, résumé) : « donnée non trouvée ».

Question : Quelle conduite (surveillance, intubation, sevrage du GHB/GBL et sa benzodiazépine), quelle fenêtre de détection toxicologique du GHB et quel statut légal (LStup, OTStup-DFI) des substances du chemsex fixent Infodrog, Tox Info Suisse ou une recommandation européenne (EMCDDA/EUDA) ? Citez la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité : titre, année, URL) qui fixe cette conduite. Comparez sa version la plus récente avec celle du cours et listez les différences. À défaut de source suisse, citez la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-049 — Moyenne — LOT 218 · SSP O6.5

Emplacement : LOT_218_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html (brouillon Appel A non audité) › Fenêtre « Bilan avant et sous hormonothérapie : interprétation » (œstradiol, testostérone, hématocrite)

Contexte : Le cours cite les cibles SSED : œstradiol 370–730 pmol/L, testostérone énanthate 14–24 nmol/L, hématocrite > 0,50–0,54 = érythrocytose ; cible de testostérone en féminisation et seuil d'arrêt de l'hématocrite non chiffrés.

Question : Quelles cibles biologiques (testostérone < seuil en féminisation, œstradiol, hématocrite d'adaptation et d'arrêt, prolactine) et quel calendrier de surveillance fixent la SSED 2026 et la recommandation européenne la plus récente (ENIGI/EAA) ? Donnez la valeur seuil validée, la population de validation (suisse ou germanophone/francophone si possible), la sensibilité et la spécificité, avec la source primaire (titre, année, URL). Signalez toute recommandation suisse ou européenne qui adopte ce seuil.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

FIN DU PAQUET HELP_Organi_P24 — 19 questions : F-038, F-039, F-040, F-041, F-042, F-043, F-035, F-036, F-037, F-044, F-045, F-046, F-048, F-050, F-051, F-052, F-053, F-056, F-049